

Polymyalgia Rheumatica (PMR) – Kortfattet Oversikt

Definisjon og klinikk Polymyalgia rheumatica (PMR) er en inflammatorisk revmatisk sykdom (en betennelsessykdom) preget av smerte og stivhet i muskler, særlig i skulder- og hofteregionen. Den rammer hovedsakelig personer over 50 år og har ofte en akutt debut. Vanlige symptomer inkluderer:

- Uttalt morgenstivhet (>1 time)
- Sidelik smerte i skuldre, nakke og hofter
- Allmennsymptomer som feber, utmattelse og vekttap

Diagnostiske kriterier Diagnosen er klinisk og støttes av:

- Forhøyet senkningsreaksjon (SR) og/eller C-reaktivt protein (CRP)
- Fravær av annen forklaring på symptomene
- Respons på lavdose glukokortikoider

Behandling Behandling er basert på glukokortikoider (prednisolon) med gradvis nedtrapping over tid. Målet er symptomfrihet med lavest mulig dose.

Behandlingsvarighet	Prednisolon dosering (mg)
Første fire uker	15
Neste fire 4 uker	12,5
Neste fire uker	10
Neste fire uker	8,75 (f.eks. 7,5 mg og 10 mg annenhver dag)
Neste fire uker	7,5
Neste fire uker	6,25 (f.eks. 5 mg og 7,5 mg annenhver dag)
Neste fire uker	5
Neste fire uker	3,75 (f.eks. 2 mg og 5 mg annenhver dag)
Neste fire uker	2,5
Neste fire uker	1,25 (f.eks 0 mg og 2,5 mg annenhver dag)
Seponering	0

Tilbakefall Ved tilbakefall (av symptomer) økes prednisolondosen til siste effektive dose før tilbakefallet. Deretter trappes dosen gradvis ned (over 4-8 uker) til nivået hvor tilbakefallet oppstod.

Tilleggsbehandling og oppfølging

- Kalsium + vitamin D tilskudd (forebygge osteoporose)

- Vurder bisfosfonater ved langvarig steroidbruk
- Monitorering av blodtrykk, blodsukker, og beinhelse
- Ved terapisvikt eller behov for steroiddose >10 mg >2 år, vurder metotreksat

Pasienten bør følges tett i starten med vurdering av SR/CRP og symptomer for å sikre adekvat respons og justere behandlingen ved behov.

Pasientens oppgave

- **Medisinsk behandling** som anført i skjema ovenfor. Prednisolon finner i 20 mg, 5 mg og 2,5 mg. Enkelte av behandlingsdosene er 1,5 mg ned fra forrige dose og er ikke tilgjengelig i enkel tablettbehandling. Dette kan løses med å ta alternerende doser (se skjema ovenfor).
- **Legen** vil ringe deg få dager etter oppstart av behandling for å høre hvordan det går.
- **Legeskontroller** må du bestille deg 8, 16 og 32 uker etter oppstart av behandling. Det er fint om blodprøvene opplistet nedenfor er tatt til legetimen.
- **Blodprøvekontroller** har du selv ansvar for å gjennomføre underveis. Det er dropin på blodprøver, men hør gjerne med helsesekretærene hvordan de ønsker å gjennomføre det. Ha med dette skrevet, slik at det blir tydelig hvilke prøver som skal tas.

Uker etter behandlingsstart	Blodprøver
4	SR, CRP
8	SR, CRP
16	SR, CRP, HbA1c, kreatnin, kalsium, D-vitamin
32	SR, CRP, HbA1c, kreatinin, kalsium, D-vitamin